

Helios Privatklinik Berlin-Buch
Schwanebecker Chaussee 50 • 13125 Berlin

Herrn
Nicolas Ziegenhagen
Schwanebecker Chaussee 50
13125 Berlin

**Zentrum für Hämatologie,
Onkologie und Palliativmedizin**

Klinik für Onkologie und Palliativmedizin
Chefarzt: Prof. Dr. med. Peter Reichardt

Tel.: (030) 9401 - 54800
Fax.: (030) 9401 - 54809

E-Mail: peter.reichardt@helios-gesundheit.de

Dokumentdatum: 12.07.2023
Druckdatum: 12.07.2023

Sehr geehrter Herr Ziegenhagen,

wir berichten über unsere gemeinsame Patientin **Zherlitsyna, Anastasiia** geb. am 25.04.1976, wohnhaft in Julii Zdanovskoi Straße 26, 03022 Kiev, die sich vom **26.06.2023** bis zum **28.06.2023** in unserer stationären Betreuung befand.

Diagnose: met. GIST des Magens (HEP); ED 08/2022
Operation: keine
Tumorformel: nicht vorliegend
Histologie: GIST (Biopsie Magen/Pankreasschwanz RF) 04/2023
Immunhistochemie: CD 117, DOG1+, CD34+, SDH B +
Molekularpathologie: Oncomine Panel (Gewebe von 08/22): BRCA 1/2, CHEK2, PALB2 negativ, KIT Mut Exon 11 (KIT Q556_V559DelinsHis Mutation) bisher 3 Fälle in der Literatur, KIF5B-MET-Translokation 284 Kopien/Mio; TMB 4,82 Mut/Mb, MSS

Nebendiagnosen: Leiomyoma des Uterus
Z. n. Pazopanib-assoziiertem PRES 01/2023
- 2x maliger Grand-mal, cerebrale Hämorrhagien 01/2023
- aktuell 1 cm großer posthämorrhagischer Defekt links okzipital

Allergien: keine bekannt

Datum:	onkologischer Verlauf:
23.08.2022	CT Thorax/Abdomen
24.08.2022	MRT Uterine leiomyosarcoma T2NxM1 (liver, sarcomatosis of the abdominal cavity, greater omentum)
29.08.2022	Biopsie Leber: Leiomyosarkom
09-12/22	4 Zyklen Gemcitabin/Docetaxel
10/2022	Komplikation: Psychose unter Dexamethason
	MRT: Leberfiliae, LL rechts S5/6 und 7 172x108mm, Segment 8 82x61mm (77x51mm) und LLlinks 75x57mm (66x42mm), Tumordinfiltrat in Projektion auf A. renalis

11/2022	sinistra 74x60mm (53x58mm), Uterus Rf 71x54x58mm (65x60x88mm)
12/2022	2xmalige Aszitespunktion
12/2022	CT-VK: Progress hepatisch, Peritonealmetastasen in CR, Primarius stabil
12/2022	frustrane Leberbiopsie
12/2022	Oncomine Panel (Gewebe von 08/22): BRCA 1/2, CHEK2, PALB2 negativ, KIT Mut Exon 11 (KIT Q556_V559DelinsHis Mutation) bisher 3 Fälle in der Literatur
04.01.2023	!!!!, KIF5B-METTranslokation 284 Kopien/Mio; TMB 4,82 Mut/Mb, MSS CT Schädel/Thorax/Abdomen: stabiler Verlauf im Vergl zu 12/22; Lebermetastasen und Tumormasse im Bereich des linken Mesogastriums und in Projektion auf das re. Ovar, leichte portal Hypertension, sek. Leberschaden (!!)
05.-12.01.2023	Pazopanib 800mg tgl. Komplikation: Bewußtseinsverlust, 2x Grand-mal
13.01.2023	cMRT: PRES okzipital, bihemispherieller Einblutungen
09.02.2023	CT Thorax/Abdomen: hepatische Metastasen und RF im linken Mesogastrium regredient
10.02.2023	1.# Zyklus Trabectedin Komplikation: Anstieg Transaminasen 3x
13.02.2023	Sturz auf Glatteis, Unterarmfraktur
02.03.2023	2.# Zyklus Trabectedin
09.03.2023	molekulares Tumorboard Mainz: Empfehlung zur Therapie mit Capmatinib bzw. Imatinib
24.03.2023	3.# Zyklus Trabectedin
11.04.2023	PET/CT: Lebermetastasen LL rechts S5/6 und 7 mit 19cm, Segment 8 101 mm und LL links mit 75mm, Tumor zwischen Magen/Pankreasschwanz gering progredient mit SUV-Anstieg (9-11); tumormanifestationen Uterus/Ovar regredient mit SUV Aufgrund dieser Beurteilung wurde die ursprüngliche Histologie Leiomyosarkom in Frage gestellt
21.04.2023	erneute Biopsie Magen/Pankreasschwanz RF
25.04.2023	Immunhistochemie: CD 117, DOG1+, CD34+, SDH B + erneute Biopsie Lebermetastase Immunhistochemie: CD 117, DOG1+ Ergebnis: Revision der Diagnose: GIST mit KIT exon 11 Mut., aber auch SDH Defizienz nachgewiesen (!)
03.05.2023	Tumorkonferenz (Issod Klinik/Israel): Bericht nicht Vorliegend
seit 05/2023	Beginn Imatinib 400mg tgl.
06/2023	Revision: CT/MRT von 08/22: GIST des Magens mit Lebermetastase, nebenbefundlich
01.06.2023	Leiomyoma Uterus und Endometrioma Ovar rechts Referenzhistologie der ersten Leber-Biopsie von 08/2023:
28.06.2023	IHC mit CD 117 und DOG1 +, SDH B Defizienz damit Bestätigung GIST CT Thorax/Abdomen: GröÙte im rechten Leberlappen bis zu 17 x 11 x 15 cm (4/105), weitere Läsionen hier von kranial im Lebersegment VIII ca. 75 x 52 mm messend (4/74) und ca. 52 x 39 mm messende hypodense Läsion im Lebersegment II Ca. 45 x 43 x 46 mm messende hypodense Läsion im linken Oberbauch mit Infiltration der Magenhinterwand (4/107) und des duodenojejunalen Überganges

Aktuell:	CT-Verlaufskontrolle: Großes Leiomyosarkom im kranialen Uterus sowie Verdickung der Cervixwand und V.a. Metastasen in der Ovarialloge bds. 2. Ausgedehnte hepatische Metastasen in beiden Leberlappen. 3. Ausgedehnte peritoneale Metastasen. Zusätzlich Metastase im Bereich der dorsalen Magenwand. MRT-Verlaufskontrolle: Bei wohl Z. n. PRES keine (ödematösen) Aktivitätszeichen. Knapp 1 cm großer posthämorrhagischer Defekt links okzipital und residuelle Blutauflagerungen bds. frontal, gut vereinbar mit einem Z.n. PRES mit Einblutungen. Sarkomkonferenz: nach Beurteilung anhand der vorliegenden schriftl. Befunde (PET/CT sowie pathologische Begutachtungen) erscheint die Revision des Leiomyosarkoms in einen GIST schlüssig. Somit Empfehlung zur Fortführung der Therapie mit Imatinib. Der Patientin wurde aber prinzipiell eine erneute histologische Sicherung zur eigenständigen Analyse durch unsere Kollegen der Pathologie angeboten. Die Patientin entschied sich zur Übersendung der Ihr demnächst vorliegenden Gewebsmaterialien zur weiteren Analyse.
Procedere:	Fortführung der Therapie mit Imatinib 400mg tgl. Wiedervorstellung der Patientin zur klinischen und bildgebenden Verlaufskontrolle in frühestens 3 Monaten nach Terminabsprache über das internationale Patientenmanagement.

Anamnese:

Die stationäre Aufnahme der Patientin erfolgt Erhebung einer Zweitmeinung bei kürzlich erfolgter Revision der ursprünglich 08/2022 erhobenen Diagnose eines metastasierten Leiomyosarkoms des Uterus in einen metastasierten GIST des Magens. Frau Zherlitsyna präsentiert sich im stabilen Allgemeinbefinden. Aktuell erfolgt eine orale Medikation mit Imatinib 400mg tgl. Hierunter verspüre die Patientin eine Fatigue. Fieber oder weitere Infektzeichen bestehend derzeit nicht.

Körperlicher Status:

Allgemein:	Wach, kooperativ, zu allen Qualitäten orientiert, EZ normosom, AZ gut.
Kopf/Hals:	Mundhöhle, Rachen reizlos, keine cerv. LKS, Pupillen isocor, LR bds. prompt
Pulmo:	VAG bds, keine RGs, keine Spastik.
Cor:	Rhythmisch, normofrequent
Abdomen:	Weich, kein DS, DG in allen Quadranten spärlich
Extremitäten:	Schlank, warm.
Haut:	Keine Effloreszenzen
Neurologie:	Kein fokalneurologisches Defizit.

ECOG: 0
Karnofsky-Index: 100
Gewicht: 62 kg
Größe: 168 cm

Therapie und Verlauf:

Es erfolgte die CT- und MRT-Verlaufskontrolle. Hier zeigt sich ein fortgeschrittenes Tumorgeschehen abdominal. Des weiteren zeigte sich nach anamnesterischer Angabe eines PRES 01/2023 ein residueller hämorrhagischer Defekt okzipital links von ca. 1cm.

Wir besprachen die vorliegende bildgebende Darstellung in Zusammenschau der vorgelegten externen Berichte in unserer Sarkomkonferenz. Leider war eine Gegenüberstellung unserer bildge-

bender Darstellung zu Voruntersuchungen aufgrund fehlender Daten nicht möglich, sodass eine Verlaufsbeurteilung nach rund 6 Wochen Imatinib Therapie nicht erfolgen konnte. Aus Sicht unserer Kollegen der Radiologie ist bildmorphologisch jedoch das Erscheinungsbild eines GIST des Magens zuzüglich hepatischer und peritonealer Metastasen sehr wohl mit der aktuell erfolgten Revision der Histologie vereinbar. Die Tumorbefunde am Uterus lassen CT-morphologisch keine weitere Einordnung zu, jedoch erscheint auch aus unserer Sicht die Differenzierung dieser Strukturen zu den Tumorbefunden des Oberbauches im Rahmen der PET/CT mit a. e. Leiomyomen des Uterus nachvollziehbar. Die externe PET/CT lag uns leider nicht digitalisierter Form vor, sodass hier einzig die Beurteilung der schriftlichen Befundung erfolgte.

Ebenso konnte keine eigenständige histologische bzw. immunhistochemische Beurteilung der extern entnommene Tumormaterialien vorgenommen werden. Auch an dieser Stelle erfolgte unsere Beurteilung anhand der vorgelegten auswärtigen Befundberichte, welche wir ebenso als schlüssig beurteilten.

Wir empfehlen daher die Fortführung der Therapie mit Imatinib. Die Patientin lehnte nach ausführlicher Diskussion über unsere Einschätzung die unmittelbar angebotene Optionen zur erneuten Stanzbiopsie und feingeweblichen Analyse ab. Sie wird sich jedoch darum bemühen die bereits entnommenen Materialien unserer Klinik zur Referenzpathologischen Beurteilung zur Verfügung zu stellen.

Wir entlassen die Patientin im stabilen Allgemeinbefinden in Ihre geschätzte ambulante Betreuung. Eine Wiedervorstellung der Patientin zur klinischen und bildgebenden Verlaufskontrolle ist in ca. 3 Monaten zu planen. Die Terminabsprache hierfür erfolgt bitte über das internationale Patientenmanagement. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen unter der Telefonnummer: 030/9401-7966 jederzeit gern zur Verfügung. Die Übermittlung von Laborkontrollen bzw. schriftlichen Dokumenten erfolgt ggf. an die Emailadresse MFA.Onkologie-Buch@helios-gesundheit.de oder per Fax an: 030/755 455-7069. Vielen Dank!

Medikament oral	Dosierung	Indikation	Anwendung
Imatinib	400mg	GIST	1-0-0
Apixaban	2,5mg		1-0-1

Bedarfsmedikation:	Dosierung	Indikation	Anwendung
Ondansetron	8 mg	Übelkeit	1-2x tgl.
Dimenhydrinat	50mg	Übelkeit	1-3x tgl.

Mit freundlichen Grüßen,

Prof. Dr. med. Peter Reichardt Nicolas Ziegenhagen
Chefarzt Oberarzt

Anhang:

cran. MRT nativ + KM i.v. + Reko vom 28.06.2023

Leiomyosarkom des Uterus T2NxM1 (Leber, Peritoneum). Pres diagn. Jan. 2023 unter TKI - Verlaufskontrolle erbeten Es liegt keine Voruntersuchung zum Vergleich vor.
Hirnstamm und Kleinhirn mit regelrechter Signalgebung. Kleinhirnbrückenwinkel

unauffällig. 4. Ventrikel normal weit. Freie basale Zisternen. Altersentsprechende Weite der inneren und äußeren Liquorräume, kein Liquoraufstau. Normale Mark-Rinden-Differenzierung. Links okzipital 9 mm große T2 hyperintense Läsion links okzipital mit angrenzendem, vermutlich gliotischen perifokalen Signalsteigerung und kortikalem Defekt, zentraler ringförmige T1 nativ hyperintensem Saum. Kein Kontrastmittelenhancement. Keine ödematösen Veränderungen. Gut 1 cm großes ringförmiges Suszeptibilitätsartefakt in dieser Region. Intersulcale Suszeptibilitätsartefakte bds. frontal. Keine Diffusionsstörung. Regelrechte Anlage und freie Pneumatisation der Nasennebenhöhlen, geringe Schleimhautschwellung in den Mastoidzellen bds. posterobasal. Keine Voruntersuchung zum Vergleich. Bei wohl Z.n. PRES keine (ödematösen) Aktivitätszeichen. Knapp 1 cm großer posthämorrhagischer Defekt links okzipital und residuelle Blutauflagerungen bds. frontal, gut vereinbar mit einem Z.n. PRES mit Einblutungen.

CT Thorax/Abdomen + KM 2 Serien vom 28.06.2023

Thorax: Einliegende Portkatheter rechts pektoral mit Spitze in der VCS. Thorakaler Weichteilmantel regelrecht. Keine pathologisch vergrößerten Lymphknoten thorakal. Keine zentrale LAE. Kein Perikarderguss. Keine Pleuraergüsse. Regelrechte Kontrastierung der supraaortalen Gefäße. Keine pneumonischen Konsolidierungen. Kein Pneumothorax. Bullöse Veränderungen im rechten Oberlappen apikal dorsal (5/15). Bullöse Veränderungen auch im linken Oberlappen (8/49). Bipulmonale Mikronoduli, exemplarisch Micronodulus im rechten Oberlappen ventral (8/78), weiterer Micronodulus im rechten Oberlappen dorsal (8/61) peri fissuraler Micronodulus im Unterlappen rechts (8/180). Weiterer Micro Nodulus im Unterlappen links (8/84). Keine pulmonalen Rundherde.

Abdomen:

Abdomineller Weichteilmantel regelrecht. Keine signifikante Menge freier Flüssigkeit intraabdominell. Keine freie Luft intraabdominell. Leber mit multiplen hypodensen teils septierten Leberläsionen exemplarisch die Größte im rechten Leberlappen bis zu 17 x 11 x 15 cm (4/105), weitere Läsionen hiervon kranial im Lebersegment VIII ca. 75 x 52 mm messend (4/74) und ca. 52 x 39 mm messende hypodense Läsion im Lebersegment II (4/89). Weitere kleine hypodense Leberläsion im Lobus caudatus ca. 15 mm messend (4/82). Multiple weitere kleine hypodense Leberläsionen betont im rechten Leberlappen. Keine Cholestasezeichen. Hepatomegalie. Gallenblase nicht abgrenzbar. Pankreasparenchym regelrecht. Milz unauffällig. Nebenniere links plump Nebenniere rechts schlank. Nieren bds. orthotop. Regelrechte kortikomedulläre Differenzierung. Kein Harnstau. Harnblase moderat gefüllt. Keine Wandverdickung. Uterus mit deutlich inhomogener Kontrastierung anteflektiert und kranial inhomogener ca. 82 x 53 mm messender Raumforderung teils mit hypodensen flüssigen Anteilen (4/150), ca. 29 x 28 mm messende inhomogene zum Uteruscorpus etwas hypodense Läsion rechts im Uterus (4/168) auch inhomogene Kontrastierung sowie Verdickung vom Cervix uteri zusätzlich rechts dorsal in der Ovarialloge ca. 59 x 50 mm messende hypodense Raumforderung (4/158) aber auch in der linken Ovarialloge kleine septierte hypodense Läsionen (10/67). Ca. 45 x 43 x 46 mm messende hypodense Läsion im linken Oberbauch mit Infiltration der Magen hinterwand (4/107) und des duodenojejunalen Überganges (4/110), im übrigen Gastrointestinaltrakt mit teils stuhlgefülltem reizlosen Colonrahmen und flüssigkeitsgefüllten Dünndarmschlingen. Keine pathologisch vergrößerten Lymphknoten abdominell. Regelrechte Kontrastierung der großen abdominellen Gefäße.

Skelett: Keine frische Fraktur. Keine malignomsuspekten Osteodestruktionen. Keine höhergradigen degenerativen Veränderungen.

1. Großes Leiomyosarkom im kranialen Uterus sowie Verdickung der Cervixwand und V.a. Metastasen in der Ovarialloge bds.
2. Ausgedehnte hepatische Metastasen in beiden Leberlappen.
3. Ausgedehnte peritoneale Metastasen. Zusätzlich Metastase im Bereich der dorsalen Magenwand.

4. Keine pulmonalen Rundherde.

NB: Gallenblase nicht abgrenzbar. Bullöse Veränderungen Oberlappen apikal bds